



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : ماجدة جلال عبدالرازق محمد

المحافظة : القليوبية الحي / المدينة : القناطر الخيرية العنوان : القليوبية

رقم البطاقة : 27810181400688 رقم التليفون : 01128330711 تاريخ تسجيل الإستمارة : 05-10-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 18-10-1978 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: التوقيع:
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: التوقيع:
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: التوقيع:
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ماجدة جلال عبدالرازق محمد National ID: 27810181400688	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

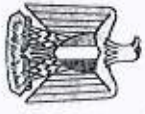
المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



 جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحقيق الشخصية
 ماجده
 جلال عبدالرازق محمد عمر
 عربية الامشي
 مركز القناطر الخيرية - القليوبية
 ٢ ٧٨ ١٠ ١٨ ١٤ ٠٠ ٦ ٨٨
 ١٦٤٢٢٧٠٧٥



 ٢٠٢١/٠٢ ٢٧٨١٠١٨١٤٠٠٦٨٨
 حاصلة على دبلوم تجارة
 انشئ
 محمد احمد صاوي حسن
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٢/٢٤ ١١


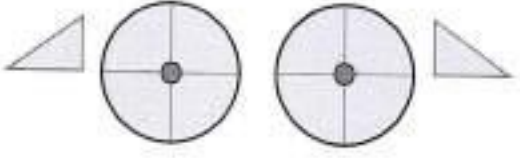
MDT FORM

3/9/2025

G

Name	ماجدة جلال عبد الرزاق	MRN	C.50/797
Age	46	ID	C.781.1816-781
Menopausal status		Phone	011 5822.211
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	

Clinical Data

BX: DX G-II				R		L	
ER:	PR:	HER 2:	KiTV:				
718	418	3					
Sonomammography: R+ USD mass 2.5 x 2.4 cm							
Mets Workup:				CT → 2 HFL 5 1.7x1.4 & 1.9x1.6 received 6 TXT 4 Herceptin kut 3/9/2025			

Recommendations: CT CAP → (SD) of HFL no comment on breast.

for next plan of management

MDT OUTCOME & PLAN CT Tr: A → Pict & mets 28/8/2025

Continue Hercept 1 HFL / 20/dec A.f

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Name: ماجدة جلال عبدالرازق محمد MR. : 5606	
Detailed Medical Report	
السيد	
تحية طيبة وبعد,,	
	إيماء للطلب المقدم من
	بقسم:
	بشأن تقرير طبي للمريض
	رقم طبي:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها	
	تاريخ وساعة الدخول :
	تاريخ وساعة الخروج :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها	
FOR C 10 HERCEPTIN 440 IV ARAMIDEX CALCIUM ONE ALPHA ECHO NEXT CYCLE ZOLADEX 10.8 AT 7/1/2026 PT RECEIVED C11 HERCEPTIN ON 2/2 FOR C12 HERCETIN IV 440 + ARAMDIEX + ZOLADEX DUE ON 1/4 PHARMACY + SUPPORTIVE echo 22/12 67% MBC TO LIVER :C13 HERCEPTIN 440+ARAMIDEX (ECHO NEXT CYCLE) NO APPROVAL FOR HER IV FOR ARIMIDEX ECHO 6/4 65% new CT CAP without comparison but free of any deposits??? next zoladex on 1/7 today for herceptin IV + arimidex + supp prem rt breast cancer ct2 no mo idc 2 er7/8 pr4/8 her23+ initial cts 2hfl met to liver rec 6 taxotere herceptin cts 8/2025 2 hfl seg 5 seg 2 m 19x14 mm ,16x15 mm st ai zoladex from 10/2025 cts 4/2026 free no hfl for c14 herceptin 440 and arimidex zoladex due date 1/7 prem rt breast cancer ct2 no mo met to liver idc 2 er7/8 pr 4/8 her23+ rec taxotere herceptin st ai from 10/2025 cts on 4/2026 no hfl free for c14 herceptin 440 and arimidex cts rd no hfl 4/2026 for c15 herceptin 440 zoladex arimidex for c16 herceptin 440 arimidex+ supp tt ECHO 19-7-2026 >> 65 % CT CAP 12-8-2026 >> RT hepatic focal lesion 18*13 mm , L3 vertebral body lesion >> comparision >> R Bone scan >> R for c18 herceptin 440 arimidex	
تحريراً في ,	
	التاريخ : 19-09-2026
	الوقت :
	هنا أسامه عبد الرحيم عبد البر
الطبيب المعالج :	
يعتمد ,	



Patient Name	: الأستاذ / ماجده جلال عبد الرازق	Request No.	: 13006986
Patient No.	: 27810181400688	Request Date	: 03/03/2025
Path No.	: SR-358/25	Verification Date	: 13/03/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 46 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Right breast upper outer quadrant mass.
Nature of Specimen: Slide Revision.

Gross Examination:

- One paraffin block labeled by (2049/25) and 3 slides were received.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): Grade II (3+2+1).
- * DCIS: Not detected.
- * Angiolinvasion: Not detected.
- * Perineural invasion: Not detected.
- * Microcalcifications: Not detected.
- * IPT:
- ER: Strong nuclear reaction in 60% of tumor cells (score 7/8).
- PR: Moderate nuclear reaction in 10% of tumor cells (score 4/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).

Diagnosis:

Right breast cancer, Slide revision:

- Invasive duct carcinoma, grade II.

IPT:

- ER: Positive (score 7/8).
- PR: Positive (score 4/8).
- Her2: Positive (score 3+).

Verified by :

Dr.Toka Medhat





Patient Name: Magda Galal Abd Al Razek Mohamed Omar	Date : 21/10/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 47 Year(s)
Medical ID: 696/2025	Pat. ID: 98175

Bilateral mammogram and BREAST HIGH RESOLUTION ULTRASONOGRAPHY REVEALED:

Indication: Follow up after neoadjuvant chemotherapy of pathologically proved right breast carcinoma

Scattered fibroglandular densities ACR B

Right breast:

- **Linear pleomorphic macrocalcifications are seen on the right UOQ region with no definite mass lesions.**
- Homogenous fatty background parenchyma.
- **Complementary US shows UOQ parenchymal distension with no definite lesions**
- Normal skin, subcutaneous fat and nipple areola complex.
- No detected significant left axillary LNs.

Left breast:

- Heterogeneous glandular background parenchyma.
- Multiple tiny cysts are seen scattered in right breast parenchyma more evident in the outer quadrant .
- Dilated clear retroareolar ducts reaching to 6 mm
- **No detected suspicious solid or cystic masses.**
- No detected significant left axillary LNs.

Conclusion:

- **Right breast:** Partial response (PR) of the pathologically proved right malignant process BIRADS 6 category.
 - **Left breast:** fibrocystic changes BIRADS 2 category.
- **Dr Farah elshobaky**

Patient Name: Magda Galal Abd Al Razek Mohamed Omar	Date : 23/08/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 47 Year(s)
Medical ID: 696/2025	Pat. ID: 98175

MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest, abdomen and pelvis obtained from the lower neck to the symphysis pubis with multiplanar reconstruction. IV contrast was used.

FINDINGS:

(I) Chest:

- Patent central air ways with well inflated both lungs.
- Both lung fields are clear showing no parenchymal nodules, cavitary lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is mildly enlarged in size showing homogenous CT density with right hepatic lobe segment 5 and left hepatic segment 2 subcapsular focal lesions , measuring 19x14 mm and 16x15 mm in diameter respectively ,showing enhancement in the delayed phase..
- Patent and homogeneously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- Bulky uterus with fundal subserous lesion ,likely fibroid.
- Pelvic phleboli are noted.
- Unremarkable other pelvic organs.

- No retrocrural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Bilateral sacroiliitis.

OPINION:

- **Clinically reported case of breast carcinoma showing:**
- **No CT evidence of pulmonary deposits.**
- **Two hepatic neoplastic focal lesions, likely metastatic.**
- **Mild hepatomegaly.**
- **Bulky uterus ? fibroid ,for sonographic correlation.**

Dr.Sara Mahmoud, MD

Patient's Name: Majeda Galal Abdulrazak
Date: 2026-08-12
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

**MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:**

Known case of breast CA.

I- CHEST:

- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Enlarged liver showing homogenous parenchymal attenuation. Right hepatic lobe segment V hypodense focal lesion measuring 18 x 13 mm. No dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal size, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Tiny L3 vertebral body lytic focus.

Opinion:

- ❖ Right hepatic lobe focal lesion for dynamic MR study.
- ❖ Tiny L3 vertebral body lytic focus for bone scan.

Dr.sherif Wagdy

Dr.sherif Wagdy

Patient's Name: Majeda Galal Abdulrazak
Date: 2026-08-12
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

**MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:**

Known case of breast CA.

I- CHEST:

- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Enlarged liver showing homogenous parenchymal attenuation. Right hepatic lobe segment V hypodense focal lesion measuring 18 x 13 mm. No dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Tiny L3 vertebral body lytic focus.

Opinion:

- ❖ Right hepatic lobe focal lesion for dynamic MR study.
- ❖ Tiny L3 vertebral body lytic focus for bone scan.

Dr.sherif Wagdy

Dr.sherif Wagdy